Escribas digitales

Funciones, mercado y condiciones de uso

¿Qué ofrecen y qué supondría incorporarlos al hospital?

- Beneficios esperados y evidencia disponible.
- Opciones comerciales, integración y costes.
- Contexto: atención en español y Dedalus HCIS.

Fuentes: Informe del proyecto. Mercado: 09/09/2026; AWS: 17/09/2026.
Literatura y comprobaciones selectivas: hasta 18/09/2026. Revisión documental, sin pruebas de productos.

Índice

Recorrido de la presentación

1. Contexto y función

2. Mercado y alternativas

3. Evidencia disponible

4. Condiciones de adopción

5. Decisión y siguientes pasos

La documentación ocupa una parte relevante del trabajo

Contexto y utilidad

49,2 %

de la jornada observada en consulta: historia electrónica y tareas de escritorio.

Estudio de referencia
57 médicos · 4 especialidades
Estados Unidos · 2016

Pregunta local
¿Cuánto trabajo documental se realiza durante la consulta, después y fuera de horario?

La cifra describe ese estudio; no estima el tiempo que un escriba ahorraría en nuestro hospital.

Fuentes: Sinsky et al., Annals of Internal Medicine, 2016.

¿Qué trabajo puede ahorrar un escriba?

Beneficio esperado · duración de consulta y carga documental

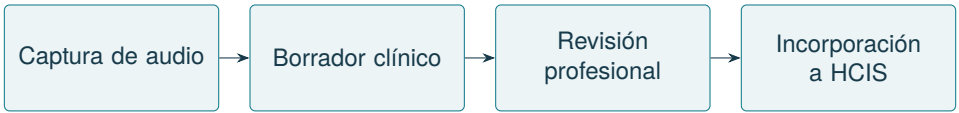
Dónde cambia el trabajo	Beneficio posible	Qué habría que medir
Durante la consulta	Menos escritura; más atención al paciente	Interacción, interrupciones y experiencia
Entre pacientes o al final del día	Menos notas pendientes y trabajo fuera de horario	Tiempo de documentación y cierre de notas
En el flujo completo	Menos trabajo total por paciente	Redacción, revisión, corrección e incorporación a HCIS

Una consulta igual de larga puede requerir menos trabajo documental. Más pacientes atendidos y mejor calidad clínica son resultados que deben demostrarse.

Fuentes: Síntesis para la evaluación local. Tierney et al., Permanente, 2025; Alcázar-Peral et al., Quirónsalud, 2026. Beneficios variables según contexto.

De la conversación a una nota revisada en HCIS

Función principal y prestaciones adicionales



- Captura desde ordenador, móvil o dispositivo dedicado.
- Plantillas para adaptar la estructura de la nota.
- Revisión, transferencia y firma pueden ser pasos distintos.

Algunas ofertas amplían el alcance: Oracle publica borradores de órdenes, resúmenes de la historia y sugerencias de codificación. Cada función requiere comprobar disponibilidad e integración.

Fuentes: NHS England, 2025; Oracle: funciones publicadas, consulta 18/09/2026. La captura y validación de cargos figura como prevista; no se incluye como función disponible.

Integrar significa completar el flujo de trabajo

Funcionalidades · Dedalus HCIS

Modalidades a distinguir

- Copiar y pegar la nota.
- Dictado en un campo.
- Transferencia del borrador.
- Integración con paciente, episodio y trazabilidad.

Demostración que interesa

- Seleccionar paciente y episodio.
- Revisar y corregir.
- Incorporar y firmar.
- Detectar y recuperar fallos.

Una alianza con Dedalus o una API no acredita un conector operativo con el HCIS local.

Fuentes: Inventario HCIS del proyecto, 09/09/2026: Tandem: HCIS; Invox Dictation: HCIS. La demostración propuesta es un requisito del proyecto.

El mercado combina productos y componentes

Panorama de mercado

43

proveedores en el inventario documental.

- **Uso individual:** suscripciones y acceso de prueba.
- **Oferta hospitalaria:** integración, soporte y contrato.
- **Componentes:** Corti y AWS HealthScribe permiten construir aplicaciones.
- **Proyectos internos:** experiencias como Quirónsalud.

Fuentes: 42 proveedores revisados el 09/09/2026; AWS añadido el 17/09/2026. Registro NHS: autocertificación; Corti; AWS HealthScribe. Muestra de mercado, no censo ni cuota de mercado.

Comprar, adaptar o desarrollar

Alternativas de implantación · responsabilidades y mantenimiento

Vía	Punto de partida	Trabajo que debe quedar cubierto
Comprar	Producto y servicios del proveedor	Contrato, integración, evaluación y soporte acordado
Adaptar código abierto	Repositorio modificable	Seguridad, configuración, conectores, pruebas y actualizaciones
Desarrollar	Componentes propios o APIs	Construcción de la aplicación y operación continuada del servicio

La muestra abierta revisada no acredita una alternativa lista para el hospital. Adaptar o desarrollar exige validar español, ENS y HCIS, y mantener el servicio.

Fuentes: Muestra exploratoria: OpenScribe; Phlox, 18/09/2026. Sin ejecución ni auditoría; búsqueda no exhaustiva. Detalles en el guion y apoyo A3.

Trabajar en español requiere evidencia específica

Comparación de opciones · calidad clínica

Qué interesa evaluar

- Omisiones y adiciones.
- Negaciones y hablantes.
- Fármacos y dosis.
- Acentos y especialidades.

Ejemplo: Heidi

Preprint de simulaciones en cinco países, incluido español en Barcelona.

Financiado por el proveedor; sin revisión por pares.

Declarar soporte multilingüe orienta la búsqueda; la calidad debe comprobarse en el contexto de uso.

Fuentes: Biro et al., 2025; Kerimoğlu et al., 2026; estudio de Heidi, preprint, 2026.

El ahorro depende de qué se mide y cómo

Evidencia · resultados objetivos y percibidos

Tiempo registrado en las notas
UCLA · ensayo aleatorizado
238 médicos · consultas en inglés

Nabla: reducción relativa del **9,5 %** frente al control. DAX: sin diferencia significativa.

Tiempo por nota percibido
Tandem · estudio observacional
Encuesta a 177 usuarios sostenidos

Reducción **autodeclarada del 29 %**. La selección de usuarios limita su interpretación.

Para el piloto interesa el ahorro neto: comparar el trabajo habitual con revisar, corregir y guardar la nota generada. Estos estudios no permiten ordenar productos por sus porcentajes.

Fuentes: Lukac et al., NEJM AI, 2025; Sanmark et al., JMIR Medical Informatics, 2026. No son medidas de pacientes adicionales atendidos.

La perspectiva del paciente también cuenta

Comparación de opciones · aceptación prevista

UC Davis: **1.893 respuestas completas** antes de la implantación.

Expectativas de mayor atención; preocupaciones sobre privacidad y exactitud.

Respuesta aproximada del 20 % de los invitados. Mide expectativas, no satisfacción ni conducta durante el uso.

Fuentes: Leiserowitz et al., JMIR Medical Informatics, 2025. Muestra de conveniencia de un centro.

Datos, seguridad y calidad: qué comprobar

Condiciones de adopción

Dimensión	Comprobación relevante
Datos	Dónde se almacenan y procesan; quién accede; retención, subencargados y contrato. Alojamiento UE no basta para acreditar RGPD.
Seguridad	ENS ALTA e ISO 27001: titular, sistema cubierto, emisor y vigencia.
Funciones sanitarias	Registrar lo que dice el médico o generar una recomendación nueva: la finalidad y las funciones pueden cambiar la clasificación regulatoria.
Calidad clínica	Errores, omisiones, revisión necesaria y resultados en español.

Fuentes: RGPD; ENS; ISO 27001; MDCG: marco europeo. TGA: ejemplo australiano, sin trasladar su clasificación a España. ENS ALTA: prioridad propuesta del proyecto.

Tres candidatos para profundizar la evaluación

Condiciones de adopción · preselección documental

Producto	Evidencia ENS ALTA	HCIS ambiental
Tandem	Certificado examinado; copia pública parcial, alcance por completar	El proveedor indica «no disponible».
Invox Genesis	Obtención anunciada; certificado y alcance Genesis pendientes	Compatibilidad de Dictation; Genesis no confirmado.
Solventum Align	Cumplimiento declarado; certificado pendiente de verificar	Conector específico no localizado.

Priorizados por ENS y presencia en España; Invox añade una referencia HCIS de dictado. La selección orienta comprobaciones: ninguno tiene acreditado todo el flujo ambiental requerido.

Fuentes: Corte: 09/09/2026. Tandem: documentación; HCIS; Invox: ENS; Dictation; Align. No localizado no significa imposibilidad técnica.

Precios de los candidatos prioritarios

Tarifas públicas y condiciones por presupuestar

Producto	Precio y cobro publicados	Presupuesto pendiente
Tandem	**Free**: gratuito. **Pro**: 125 €/usuario/mes, con anualidad. **Enterprise**: a medida; usuario/mes.	Enterprise, integración HCIS, implantación e impuestos.
Invox Genesis	Sin tarifa ni unidad facturable públicas localizadas.	Usuarios o consumo, límites, implantación, HCIS y soporte.
Solventum Align	Sin tarifa ni volumen incluido públicos localizados.	Licencias, alcance del paquete, implantación, HCIS y soporte.

El coste total requiere integración, equipos, formación y soporte para el mismo escenario de actividad. Aún no hay presupuestos comparables.

Fuentes: Páginas revisadas el 18/09/2026: Tandem; Genesis; Align. Free tiene funciones limitadas y no acredita integración HCIS.

Qué enseñan los despliegues

Resultados y consecuencias para el hospital

Experiencia	Resultado y límite de interpretación
Quirónsalud España	Consulta media: 15,01 min con Scribe y 14,65 sin él; mejor experiencia percibida. Sin medidas de trabajo fuera de horario ni resultados clínicos.
Permanente Estados Unidos	Menor tiempo en notas y fuera de horario frente a no usuarios. Comparación observacional; capacidad asistencial adicional no demostrada.
Cleveland Clinic Ambience	Despliegue apoyado en gobernanza, formación y soporte. La adopción requiere organización además de licencias.

Medir por separado documentación, experiencia, calidad clínica y capacidad asistencial. La mejora en una dimensión no acredita las demás.

Fuentes: Alcázar-Peral et al., 2026; Tierney et al., 2025; Merlino et al., 2026. Diseños observacionales/descriptivos; Cleveland Clinic incluye coautoría del proveedor.

El siguiente paso puede ser una exploración acotada

Implicaciones para el hospital · propuesta para discusión

1. **Definir el uso:** servicios, profesionales, equipos y beneficio prioritario.
2. **Resolver condiciones:** datos, seguridad, demostración HCIS y presupuesto comparable.
3. **Evaluar progresivamente:** casos comunes y, después, piloto limitado si procede.

La decisión inicial es qué merece la pena explorar y con qué condiciones.

Fuentes: Propuesta del informe, secciones 6–7 y apéndice F. Protocolo pendiente; opciones de diseño apoyadas en Lukac et al. y Biro et al..

Gracias

Preguntas y prioridades para el hospital

- ¿En qué servicios tendría sentido explorar su uso?
- ¿Qué condiciones de datos, integración y coste son necesarias?

Opciones para definir una evaluación

Apoyo A1 · protocolo pendiente

- **Casos comunes:** audio o simulaciones, contexto equivalente y revisión clínica independiente.
- **Efecto asistencial:** comparar el flujo habitual y el uso del escriba; antes/después o grupo contemporáneo según viabilidad.
- **Resultados:** errores residuales, tiempo completo, uso y abandono, experiencia, fallos y coste.
- **Decisiones previas:** muestra, formación, versiones y criterios de continuidad.

Un banco de consultas compara notas; el ahorro asistencial requiere observar el trabajo real.

Fuentes: Biro et al.; Lukac et al.; DECIDE-AI: criterios de reporte. Adaptación propuesta en el apéndice F del informe.

Evidencia aportada por otros proveedores

Apoyo A2 · evidencia, no clasificación de eficacia

Proveedor	Aportación al análisis	Límite relevante
Heidi	Simulación que incluye español	Preprint financiado por el proveedor.
Nabla	Ensayo aleatorizado con DAX y control	Un centro, inglés; versiones estudiadas.
Abridge	263 profesionales en seis sistemas; bienestar antes/después	Autodeclarado, sin control contemporáneo, coautoría del proveedor.
Ambience	Despliegue a gran escala	Informe organizativo, no comparación clínica.

Fuentes: Heidi; Lukac et al.; Olson et al.; Merlino et al.. Los estudios no acreditan ENS ALTA ni HCIS.

Fuentes y alcance de la revisión

Apoyo A3 · detalle para consulta

- Mercado inicial: 09/09/2026. AWS: 17/09. Literatura y comprobaciones selectivas: hasta el 18/09; las fechas figuran en cada slide.
- Código abierto: dos repositorios explorados, sin ejecución ni auditoría. OpenScribe combina rutas locales y externas; Phlox se declara experimental. No se presentan como candidatos hospitalarios validados.
- Desarrollos de investigación como Y-KNOT no equivalen a una aplicación ambiental abierta y reutilizable: su código no es público.

Codex y ChatGPT apoyaron parcialmente la búsqueda, estructuración y organización de referencias. La selección crítica y la responsabilidad sobre la versión final corresponden al autor.

Fuentes: Informe y notas del proyecto; OpenScribe; Phlox, consulta 18/09/2026; Y-KNOT. Guion y fuentes ampliadas en guion-presentacion.md.